

黑河市医疗保障局文件

黑市医保发〔2020〕37号

关于印发《黑河市基本医疗保险 保险门诊慢性病鉴定标准》的通知

各县（市、区）医疗保障局、风景区人力资源和社会保障局，市基本医疗保险经办服务中心、市直定点医疗机构：

现将《黑河市基本医疗保险门诊慢性病鉴定标准》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。



黑河市基本医疗保险门诊慢性病鉴定标准

一、高血压（III期以上）（重度高血压）

原发性重度高血压：在排除假阳性前提下，非同日测量三次血压值收缩压均大于等于 180mmhg 和（或）舒张压大于等于 110mmhg；继发性高血压有明确的原发病因素，同时符合原发性重度高血压数值标准；妊娠期高血压证实生产时血压升高，确定为产后 1 年血压仍升高者，并符合原发性重度高血压数值标准。

轻度和中度高血压不在待遇给付范围。

鉴定要点：现场鉴定，由 2 名医师同日内先后测量，数值误差在上下 10mmhg 以内有效，连续测量 3 日，每日 1 次。

二、风湿性心脏病（心功能不全 3 级以上）

（一）风湿热病史

按 1992 年美国心脏病协会修订的风湿热诊断标准，确诊首发急性风湿热标准：前驱的链球菌感染证据，咽喉试子或快速链球菌抗原试验阳性、链球菌抗体效价升高，同时有 2 项主要表现或 1 项主要表现加 2 项次要表现者。主要表现包括：A 心脏炎；B 多发性红斑；C 舞蹈病；D 环形红斑；E 皮下结节。次要表现包括：A 关节痛；B 发热；C esr、crp 升高；D P-R 间期延长。

确诊复发风湿热标准：1、存在舞蹈病的；2、隐匿发病或缓慢发展的心脏炎的；3、过去确诊过风湿热或者正在患风湿性心

脏病的。以上三种情况中，只要现有前驱的链球菌感染证据，其中任何一项诊断风湿热都成立。这里包含 2 层意思，过去是否存在风湿热，不确定，但本次确认；过去确认有，但本次病情是否复发，可以确认。

注：达不到标准又可疑风湿热者，不能给与待遇。2002-2003 年 WHO 修订标准不做依据。

（二）风湿性心脏瓣膜病诊断标准

1、二尖瓣狭窄：结合临床症状和体征，X 检查和心电图支持诊断，超声心动图显示二尖瓣口狭窄达到中度以上。

注：中度狭窄，平均压力差 5-10mmhg，肺动脉压 30-50mmhg，瓣口面积 1.0-1.5cm²；重度狭窄，平均压力差>10mmhg，肺动脉压>50mmhg，瓣口面积<1.0cm²。

2、二尖瓣关闭不全（慢性）：结合临床症状和体征，X 检查和心电图支持诊断，彩色多普勒血流显像半定量及定量诊断二尖瓣口反流达到中度以上。

注：定量及半定量诊断标准：

半定量诊断标准为：若反流局限于二尖瓣环附近为轻度，达到左房中部为中度，直达心房顶部为重度。

定量诊断标准为：轻度是指射流面积<4cm、每次搏动的反流量<30ml、反流分数<30%；中度是指射流面积为 4~8cm²、

每次搏动的反流量 30 ~ 59ml、反流分数为 30 % ~ 49 %；重度是指射流面积 > 8cm²、每次搏动反流量 > 60ml、反流分数 > 50 %。

3、主动脉瓣狭窄：结合临床症状和体征，X 检查和心电图支持诊断，超声心动图连续多普勒测速诊断主动脉瓣口反流达到中度以上。

注：超声心动图连续多普勒测速诊断主动脉瓣口反流标准：
轻度：射流速度 < 3m/s, 平均压力差 < 25mmHg, 瓣口面积 > 1.5cm²；
中度：射流速度 3 ~ 4m/s, 平均压力阶差 25 ~ 40mmHg, 瓣口面积 1.0 ~ 1.5cm²；重度：射流速度 > 4m/s, 平均压力阶差 > 40mmHg, 瓣口面积 < 1.0cm²。

4、主动脉瓣关闭不全：结合临床症状和体征，X 检查和心电图支持诊断，彩色多普勒超声显示主动脉关闭不全中度以上反流。

注：主动脉反流程度诊断标准：轻度：射流宽度 < 左心室流出道的 25 %，每次搏动的反流量 < 30ml，反流分数 < 30 %；中度：射流宽度为左心室流出道的 25 % ~ 65 %，每次搏动的反流量 30 ~ 59ml，反流分数为 30 % ~ 49 %；重度：射流宽度 > 左心室流出道的 65 %，每次搏动的反流量 > 60ml，反流分数 > 50 %。

5、多瓣膜病：在上述疾病诊断基础上诊断。

以上瓣膜病，必须诊断风湿热病史作为前提，并且以二尖瓣

狭窄为主，除此之外，其他瓣膜病病因上风湿热占比不绝对，故不能做轻易界定。

黏液样变性、老年瓣膜钙化退行性改变、先天性心脏病、类癌瘤、结缔组织病、病毒感染等非风湿热导致的心脏瓣膜病变不在待遇给付范围、单纯感染性心内膜炎累及瓣膜不在待遇给付范围。

风湿性心脏病患者不允许再申请患心房颤动门诊用药待遇。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断风湿热及瓣膜病的完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。

三、肺源性心脏病（慢性心力衰竭）

（一）符合慢阻肺界定标准，见慢阻肺界定标准。

（二）结合临床症状和体征。

（三）符合 X 诊断标准：

1、右下肺动脉干扩张，其横径 $\geq 15\text{mm}$ 或其右下动脉横径与气管横径比值 ≥ 1.07 ，或动态观察右下动脉干增宽 $> 2\text{mm}$ ；2.肺动脉段明显突出或其高度 $\geq 3\text{mm}$ ；3.中心肺动脉扩张和外周分支纤细，形成残根征；4.圆锥部明显凸出（右前斜位 45 度）或其高度 $\geq 7\text{mm}$ ；5 右心室增大。具备上述任一条均可诊断。

（四）有符合肺心病的心电图、超声心动图的表现作为支持诊

断。

以上符合慢阻肺待遇标准同时符合 X 线诊断标准作为硬性指标，二者缺一不可。

特发性肺动脉高压，左心病变引起的肺动脉高压、肺血栓栓塞症引起的肺动脉高压导致的急性肺心病、支气管哮喘和支气管扩张症、肺结核、间质性肺疾病引起的肺心病不能在此界定慢性肺心病待遇。

鉴定要点：审查病历资料鉴定并结合现场鉴定。提供三级乙等（含以上）医院诊断肺心病的完整住院病历，根据标准由专家对病历及现场结果进行核定。

四、冠心病（心功能不全 3 级以上）

（一）稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛：冠脉造影证实符合支架标准，即单只血管狭窄 75% 以上行支架植入术的；弥漫性冠状动脉远端病变等因素但无法植入支架的、行冠状动脉旁路移植术的。

（二）非 ST 段抬高型心肌梗死、急性 ST 段抬高型心肌梗死：1、符合心肌梗死的临床表现和体征。2、心电图的特征性改变、动态性改变及定位改变。3、有血清心肌坏死标志物支持。4、超声心动图作辅助性诊断。

以上 1、2、3 为必须项，具体内容标准：

1、晨起 6 时至 12 时交感神经活动增加，机体应激反应性增强，心肌收缩力、心率、血压增高，冠状动脉张力增高。

2、在饱餐特别是进食多量脂肪后，血脂增高，血粘稠度增高。

3、重体力活动、情绪过分激动、血压剧升或用力大便时，致左心室负荷明显加重。

血管痉挛性心绞痛（变异性心绞痛）、无症状心肌缺血（隐匿型冠心病）、X 综合征、心肌桥、主动脉狭窄或关闭不全、风湿性冠脉炎、梅毒性主动脉炎、肥厚性心肌病引起的冠脉供血不足不能界定待遇。

单凭心电图偶然发现陈旧性心肌梗死，无临床症状，也无超声心动图及心肌酶学标志物检查支持，不能鉴定心肌梗死。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。至少要求提供二级甲等（含以上）医院诊断冠心病的完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。

五、脑血管疾病后遗症（合并肢体功能障碍）

（一）确诊脑梗死（脑血栓形成或脑栓塞）或脑出血

1、病史：伴或不伴有基础疾病的病史，如高血压、房颤、动脉粥样硬化等；

2、临床表现：急诊发病，临床表现出现相应的神经定位体

征，即脑功能缺损综合征，ct 或 MRI 确诊脑出血或脑梗死（不限范围、部位、血管分布）。

3、发病治疗期间表现一定程度的脑功能缺损综合征，特别是肢体功能和（或）言语功能障碍，程度要达到“（二）”中所要求级别。

（二）肢体功能障碍评定标准：脑卒中神经功能缺损综合征经历急诊住院治疗、后期康复治疗，半年内神经功能可以一定程度的恢复，故申请标准定为出院后 6 个月，仍留有神经功能缺损后遗症的，具体标准如下：

1、单肢肌力，按 Lovett 分级，肌力在 3 级（包括 3 级）以下。

2、瘫痪卧床，并发肺感染、关节僵硬、静脉血栓形成、褥疮等。

3、植物人状态。

以上 1-3 中，具备一现既符合条件。

注：Lovett 分级：

0 级 完全瘫痪，肌肉无收缩。

1 级 肌肉可收缩，但不能产生动作。

2 级 肢体能在床面上移动，但不能抵抗自身重力，即不能抬起。

3 级 肢体能抵抗重力离开床面，但不能抵抗阻力。

4 级 肢体能抗阻力动作，但不完全。

5 级 正常肌力。

(三) 以下疾病不能界定脑出血或脑梗死留有严重肢体功能障碍待遇给付标准

1、其他疾病导致的身体功能缺陷，如各种外伤导致的颅脑损伤、意外中毒留有的肢体功能障碍、肿瘤、脊柱疾病等引起的肢体功能不全。

2、短暂性脑缺血发作、蛛网膜下腔出血、脑血管畸形引起的脑出血、腔隙性脑梗死（无症状性脑梗死）、颅内动脉瘤、颅内血管畸形、脑动脉盗血综合征、颅内异常血管网症、动脉肌纤维发育不良、淀粉样血管病、血液病、动脉壁夹层病变、遗传性脑血管病、脂肪栓塞、空气栓塞、寄生虫栓塞、异物栓塞等引起的脑卒中。

鉴定要点：审查病历资料鉴定并结合现场鉴定。至少要求提供二级甲等（含以上）医院诊断脑卒中的完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。同时在脑卒中半年后由专家对其进行肢体功能评定。

六、肝硬化失代偿期（乙型肝炎或丙型肝炎）

(一) 病毒性肝炎诊断标准：

HBV:HBsAG 和 HBVDNA 阳性。

HCV: HCVIgM 和或 IgG 阳性, HCV RNA 阳性

(二) 肝硬化失代偿期诊断标准:

1、肝功能减退

(1)、临床表现: 消化吸收不良、营养不良、黄疸、出血和贫血、不孕不育、蜘蛛痣、肝掌、肝病面容、男乳发育、肝性脑病及食管胃底静脉曲张出血等。

(2)、实验室检查: 血清白蛋白低于 35g/L、血浆凝血因子降低、PT 和 APTT 及凝血酶时间延长; 胆固醇水平降低。生化检测转氨酶升高、胆红素升高, 出现黄疸; 肝功能(化验单)改变(相关酶学, 白、球蛋白、胆红素)。

2、门静脉高压: a 表现脾大、腹水、侧支循环的建立, 如食道和胃底静脉曲张、腹壁静脉曲张等; b 实验室检查, 血小板、红细胞、白细胞降低; c、B 超、CT 或 MRI 证实脾大腹水肝脏形态变化, 彩色 B 超门静脉主干内径大于 13mm、脾静脉内径大于 8mm, B 超、CT 或 MRI 全面评估门静脉高压状态, 如出现侧支循环开放、门静脉血栓、血管海绵样变及动静脉瘘; d、胃镜证实食道和胃底静脉曲张。

3、证实肝硬化并发症: a、上消化道出血; b、胆结石; c、自发细菌性腹膜炎、胆道感染; d、门静脉血栓或海绵样变; e、

肝肾综合征；f、肺肾综合征；g、原发性肝癌；f、肝性脑病。

4、有因肝硬化脾切除史。

5、肝穿病理证实肝硬化。表现肝慢性纤维化、假小叶和再生结节形成。

注：以上项目中，“（一）”做前提界定，“（二）‘1’”做支持诊断，“（二）中 2、3、4、5”任何一项存在诊断均成立。但单纯凭影像学证明肝脏形态改变确诊肝硬化而无门静脉高压的证据，不能界定肝硬化失代偿期。

鉴定要点：审查病历资料鉴定并结合现场鉴定。至少要求提供三级乙等医院(含以上)诊断肝硬化失代偿期的完整住院病历，根据标准由专家对病历及现场结果进行核定。

七、慢性肾脏病(III期以上)（界定 3 期 4 期，5 期按尿毒症政策管理）

（一）可存在慢性肾脏病病因：糖尿病肾病、高血压肾小动脉硬化、肾小球肾炎、肾小管间质疾病、肾血管疾病、遗传性肾病、其他不明原因的肾病。

（二）肾功能衰竭的临床表现：

- 1、水、电解质代谢紊乱。
- 2、蛋白质、糖类、脂类和维生素代谢紊乱。
- 3、相关的心血管系统表现。

- 4、相关呼吸系统症状。
- 5、相关的胃肠道症状。
- 6、相关的血液系统表现。
- 7、神经肌肉系统表现。
- 8、内分泌功能紊乱。
- 9、相关的骨骼病变。

要求：至少存在一个以上系统的临床表现。

（三）肾功能检测：要求肾脏分期达到3期（含）以上。

1期：GFR正常或升高，大于等于90，（GFR单位：ml/min.1.73平方米，下同）。

2期：GFR轻度降低，60至89。

3期：轻度到重度降低，30至59。

4期：重度降低，15至29。

5期：ESRD,小于15，或透析。

（四）血液、尿液相关检测，出现成分异常。如尿蛋白、尿素氮肌酐等。

（五）B超、CT、MRI检查出现肾脏形态学改变。

（六）肾脏穿刺活检，证实肾脏病变。

以上（一）至（六）项，全面综合考虑，确诊慢性肾脏病及相应分期。其中（三）为必须项目，六项为可选项目。

急性肾损伤(急性肾衰竭),不能界定慢性肾脏病三期。

终末期肾病(ESRD),即尿毒症期按尿毒症门诊透析治疗政策管理,不在此处享受待遇。享受尿毒症政策,不再享受此政策。

鉴定要点:审查病历资料鉴定并结合现场鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断慢性肾脏病的完整住院病历,根据标准由专家对病历及现场结果进行核定。

八、糖尿病慢性并发症

(一) 确诊糖尿病

伴有糖尿病症状,化验检查:葡萄糖氧化酶法 $\text{fpg} \geq 7.0\text{mmol/L}$; 或 $\text{igt}(2\text{h}) \geq 11.1\text{mmol/L}$, 结合 $\text{HbA}_{1c} \geq 6.5\%$, 排除偶发血糖升高(非同日重复检测2次), 确诊糖尿病。

(二) 慢性并发症诊断标准

- 1、心脏并发症。按冠心病标准界定,见冠心病界定标准。
- 2、脑部并发症。脑血管疾病遗留后遗症标准界定,见脑血管疾病遗留后遗症界定标准。
- 3、肾脏并发症。慢性肾脏病3期标准界定,见慢性肾脏病三期界定标准。
- 4、糖尿病性视网膜病变:达到2期或以上。

糖尿病眼底病变具体表现为:1级微血管瘤、出血;2级微血管瘤,出血并有硬性渗出;3级出现棉絮状软性渗出;4级新

生血管形成，玻璃体出血；5级机化物增生；6级继发性视网膜脱离，失明。

5、糖尿病性周围神经病变。排除其他病因引起的神经病变如外伤、脊柱疾病等。

(1) 伴肢端感觉异常；(2) 电生理检查感觉和运动神经传导速度减慢。

本项(2)为必备条件。

6、糖尿病足。足部溃疡、感染和(或)深层组织破坏，甚至截肢结局。排除外伤等非糖尿病因素引起的足部病变。

要求至少足部一处出现明显的病变，表现皮肤糜烂、溃疡甚至深层组织破坏才可以定诊。单纯的足部暗斑或划痕但无明显破溃不能定诊。

7、糖尿病性白内障。达到白内障成熟期，过熟期，经手术治疗后界定。

8、合并恶性肿瘤。确诊恶性肿瘤患者，直接界定糖尿病慢性并发症。

以上在(一)的基础上，(二)中的9项中任何1项符合标准，界定成立。

鉴定要点：审查病历资料鉴定并结合现场鉴定。心、脑、肾、白内障、恶性肿瘤并发症至少要求提供二级甲等(含以上)医院

相关疾病的完整住院病历，其他并发症采取现场鉴定。根据标准由专家对病历及现场结果进行核定。

九、再生障碍性贫血

（一）再生障碍性贫血界定标准。

实验室检查：1、全血细胞减少，网织红细胞百分数小于0.01，淋巴细胞比例偏高；2、一般无肝脾大；3、骨髓多部位增生减低，低于50%，或重度减低，低于25%，造血细胞减少，非造血细胞比例增高，骨髓小粒空虚；4、除外以其他疾病，确诊再障。

（二）重型再生障碍性贫血界定标准。

- 1、网织红细胞 <0.01 ，绝对值 $<15\times10^9/L$ ；
- 2、中性粒细胞绝对值 $<0.5\times10^9/L$ ；
- 3、血小板 $<20\times10^9/L$ 。

以上（“二”）血象中3项具备任何2项即可诊断重型再障。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断再障的完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。

十、类风湿性关节炎（有严重肢体功能障碍）

（一）类风湿性关节炎诊断依据《内科学》第八版第812页表8-3-2即2010年ACR/EULAR的分类及评分标准执行，要求评分6分（含）以上确诊。

(二)关节功能障碍评级标准按美国风湿病学会分级标准执行,要求达到Ⅲ级及以上,并同时具备x线片显示骨关节病变Ⅲ期以上。

注:美国风湿病学会关节功能障碍分级标准:I级,能照常进行日常生活和各项工作;Ⅱ级,可进行一般的日常生活和某种执业工作,但参与其他项目活动受限;Ⅲ级,可进行一般的日常生活,但参与某种职业工作或其他项目活动受限;Ⅳ,日常生活的自理和参与工作能力均受限。

X平片骨关节病变分期标准:I期,关节周围软组织肿胀影、关节端骨质疏松;Ⅱ期,关节间隙变窄;Ⅲ,关节面出现虫蚀样改变;Ⅳ,关节半脱位和关节破坏后的纤维性和骨性强直。

以上(一)、(二)同时成立,界定成立。

鉴定要点:审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断类风湿性关节炎的完整住院病历,根据标准由专家对病历进行核定。

十一、系统性红斑狼疮

- 1、颊部红斑:固定红斑,扁平或高起,在两颧突出部位。
- 2、盘状红斑:片状高起于皮肤的红斑,粘附有角质脱屑和毛囊栓;陈旧病变可发生萎缩性瘢痕。
- 3、光过敏:对日光有明显的反应,引起皮疹,从病史中得

知或医生观察到。

4、口腔溃疡：经医生观察到的口腔或鼻咽部溃疡，一般为无痛性。

5、关节炎：非侵蚀性关节炎，累及 2 个或更多的外周关节，有压痛，肿胀或积液。

6、浆膜炎：胸膜炎或心包炎。

7、肾脏病变：尿蛋白大于 0.5g/24h,或管型（红细胞、血红蛋白、颗粒或混合管型）。

8、神经病变：癫痫发作或精神病，除外药物或已知的代谢紊乱。

9、血液学疾病：溶血性贫血，或白细胞减少，或淋巴细胞减少，或血小板较少。

10、免疫学异常：抗 dsDNA 抗体阳性，或抗 sm 抗体阳性，或抗磷脂抗体阳性（包括抗心磷脂抗体、或抗狼疮抗凝物或至少 6 个月的梅毒血清学试验假阳性三者中具备一项阳性）。

11、抗核抗体：在任何时候和未用药物诱发“药物性狼疮”的情况下，抗核抗体滴度异常。

符合上述 4 项或以上者，排除感染、肿瘤及其他结缔组织病者，界定成立。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院

诊断系统性红斑狼疮的完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。

十二、严重精神障碍疾病

(一) 精神分裂症。

沈渔邨精神病学（第六版）、ICD-10 诊断标准

1、症状标准具备下述(1)~(4)中的任何一组(如不甚明确常需要两个或多个症状)或(5)~(9)至少两组症状群中的十分明确的症状。

(1)、思维鸣响、思维插入、思维被撤走及思维广播。

(2)、明确涉及躯体或四肢运动，或特殊思维、行动或感觉的被影响、被控制或被动妄想、妄想性知觉。

(3)、对患者的行为进行跟踪性评论，或彼此对患者加以讨论的幻听，或来源于身体某一部分的其他类型的幻听。

(4)、与文化不相称且根本不可能的其他类型的持续性妄想，如具有某种宗教或政治身份，或超人的力量和能力(如能控制天气，或与另一世界的外来者进行交流)。

(5)、伴转瞬即逝或未充分形成的无明显情感内容的妄想，或伴有持久的超价观念，或连续数周或数月每日均出现的任何感官的幻觉。

(6)、思潮断裂或无关的插入语，导致言语不连贯，或不中

肯或语词新作。

(7)、紧张性行为，如兴奋、摆姿势，或蜡样屈曲、违拗、缄默及木僵。

(8)、阴性症状，如显著情感淡漠、言语贫乏、情感迟钝或不协调，常导致社会退缩及社会功能下降，但须澄清这些症状并非由抑郁症或神经阻滞剂治疗所致。

(9)、个人行为的某些方面发生显著而持久的总体性质的改变，表现为丧失兴趣、缺乏目的、懒散、自我专注及社会退缩。

2、严重程度标准无。

3、病程标准特征性症状在至少 1 个月以上的大部分时间内肯定存在。

4、排除标准。

(1)、存在广泛情感症状时，就不应做出精神分裂症的诊断，除非分裂症的症状早于情感症状出现。

(2)、分裂症的症状和情感症状两者一起出现，程度均衡，应诊断分裂情感性障碍。

(3)、严重脑病、癫痫、药物中毒或药物戒断状态应排除。

(二) 双相情感障碍。

沈渔邨精神病学（第六版）、ICD-10 双相情感障碍诊断标准：

注：界定为一次发作后需有反相或混合相发作，或维以缓解状态。双相情感障碍（注：界定为一次发作后需有反相或混合相发作，或维以缓解状态。双相情感障碍（F31）的诊断需符合两条标准：本次发作符合上述某种发作的标准；既往至少有过一次其他情感障碍发作。如本次为某种类型的抑郁发作，则既往需要至少一次轻躁狂、躁狂或混合性情感障碍发作。

F31.0 双相情感障碍，目前为轻躁狂。

F31.1 双相情感障碍，目前为不伴有精神病性症状的躁狂发作。

F31.2 双相情感障碍，目前为伴有精神病性症状的躁狂发作。

F31.20 与心境相协调的精神病性症状。

F31.21 与心境不协调的精神病性症状。

F31.3 双相情感障碍，目前为轻度或中度抑郁发作。

F31.30 不伴躯体症状。

F31.30 伴有躯体症状。

F31.4 双相情感障碍，目前为重度抑郁发作，不伴精神病性症状。

F31.5 双相情感障碍，目前为重度抑郁发作，伴有精神病性症状。

F31.6 双相情感障碍，目前为混合状态

1、本次发作以轻躁狂、躁狂和抑郁症状混合或交替（即在数小时内）为特点。

2、至少在 2 周期间的大部分时间内躁狂和抑郁症状必须同时突出。

3、既往至少有过一次确定无疑的轻躁狂或躁狂发作、抑郁发作混合性情感发作。

F31.7 双相情感障碍，目前为缓解状态。

1、目前状态不符合任何严重度的抑郁或躁狂发作的标准，也不符合任何一种其他的情感障碍标准（可能因为在接受降低复发危险的治疗）。

2、既往至少有过一次确定无疑的轻躁狂或躁狂发作，同时外加至少一种其他的情感发作（轻躁狂或躁狂、抑郁或混合型发作）。

（三）偏执性精神障碍（妄想性障碍）

沈渔邨精神病学（第六版）、ICD-10 诊断标准：

1、存作一个（或多个）妄想，时间持续至少三个月。

2、从不符合精神分裂症的诊时标准 A。A。注：如果存在幻觉，则不突出，并且与妄想的主题相关（例如，与昆虫大批出没的妄想有关的被昆虫寄生的感觉）。

3、除了受妄想或其结果的影响，功能没有明显损害，没有

明显的离奇或古怪行为。

4、如果出现躁狂或重性抑郁发作，则这些发作对于妄想的病程而言是短暂的。

5、这种障碍不能归因于某种物质的生理效应或其他躯体疾病，且不能用其他精神障碍来更好地解释，如躯体变形障碍或强迫障碍。

分型

钟情型：妄想的核心主题是另一个人钟爱自己。

夸大型：妄想的核心主题是个体坚信自己有一些伟大的（但未被认可的）天赋、洞察力或取得了一些重大的发现。

嫉妒型：妄想的核心主题是他/她的配偶或爱人不忠。

被害型：妄想的核心主题涉及个体的信念，即他/她认为被阴谋算计、被欺骗、被监视、被跟踪、被投毒或被下药、被恶意诽谤、被骚扰，或被妨碍追求长期目标。

躯体型：妄想的核心主题涉及躯体的功能或感觉。

混合型：此亚型适用于没有一个妄想主题占主导地位的情况。

未特定型：占优势地位的妄想信念不能被清楚地确定或其特定类型不能被清楚地确定或其特定类型不能被清楚地描述（例如，关系妄想中没有突出的被害或夸大的成分）。

（四）分裂情感性障碍。

沈渔邨精神病学（第六版）、ICD-10 诊断要点

1、在疾病的同一次发作中，明显而确实的分裂性症状和情感性症状同时出现或只差几天，因而该发作既不符合精神分裂症也不符合抑郁发作或躁狂发作的标准。

2、有些患者出现反复发作的分裂情感性发作，可为躁狂型或抑郁型，也可为两型之混合，即混合型，此时应诊断为分裂情感性障碍。

3、如果在疾病的不同发作中分别表现出分裂性症状和情感性症状，则分别根据当时症状进行诊断，不诊断为分裂情感性障碍。

4、有些患者可在典型的躁狂发作或抑郁发作之间插入一到两次分裂情感发作，这种偶然出现的分裂情感性发作并不能推翻双相情感障碍或反复发作性抑郁障碍的诊断。

5、不同亚型分裂情感性障碍诊断要点。

躁狂型：在疾病的同一次发作中分裂性症状和躁狂症状均突出。

抑郁型：在疾病的同一次发作中分裂性症状和抑郁症状都很突出。

混合型：精神分裂症症状与混合型双相情感性障碍同时突出。

（五）精神发育迟滞伴发精神障碍（精神发育迟滞，显著的

行为缺陷，需要加以关注或治疗）。

沈渔邨精神病学（第六版）临床诊断。

需要全面采集病史、精神检查和躯体检查，其中详细的生长发育史特别重要，据此可对儿童生长发育情况做出全面的临床评估。同时，根据年龄和智能损害的程度选择适用于患者的标准化发育量表或智力测验，如韦氏智力测验评估智商，儿童社会适应行为评定量表评估社会适应能力。若儿童 18 岁以前出现智力低下和社会适应困难的临床表现，智力测验结果显示智商低于 70，则可诊断为精神发育迟滞。再根据智商确切值及社会适应能力判断智力发育障碍的严重程度。对于精神发育迟滞患者伴有的幻觉、妄想等精神病性症状，或严重的易激惹、攻击行为和破坏行为则诊断为精神发育迟滞伴发精神障碍。

（六）癫痫所致精神障碍（癫痫性精神病）。

沈渔邨精神病学（第六版）诊断。

癫痫所致精神障碍在原发性和继发性癫痫患者中均可发生，在癫痫发作前、发作时、发作后和发作间产生，亦可表现为持续的精神障碍。

本病诊断主要根据既往有癫痫发作史，临床精神症状呈发作性，每次发作的表现基本相同，发作时伴有不同程度的意识障碍。特别是脑电图检查对癫痫的诊断有重要价值，90%的癫痫患者有

脑电图的异常。对病程长而不典型者则需要多次重复进行脑电图检查，必要时尚可给予抗癫痫药物进行诊断性治疗，若精神症状及脑电图可在用药后均有改善，则可作为诊断的依据。

注：严重精神障碍诊断标准来源：沈渔邨精神病学（第六版）及 ICD-10 精神与行为障碍分类。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。要求提供黑龙江省精神病防治院诊断严重精神障碍疾病的权威病历，根据标准由专家对病历进行核定。

十三、活动性结核病

具有结核病相关的临床症状和体征，结核分枝杆菌病原学、病理学、影像学等检查有活动性结核的证据。

1、结核病症状。

（1）、咳嗽、咳痰 ≥ 2 周、咯血和血痰是肺结核病的主要症状，具有以上任何一项症状者为肺结核可疑症状者。

（2）、胸闷、胸痛、低热、盗汗、乏力、食欲减退、体重减轻等为肺结核患者的其他常见症状。

（3）、儿童结核症状：营养不良、发育迟缓。

（4）、肺外结核：相应脏器受累症状。

2、结核病病原学检测。

细菌学检查：涂片、培养 阳性。

分子生物学检查 阳性。

3、组织病理学检查为结核病变。

4、影像学检查。

胸部 X 线摄影或胸部电子计算机体层摄影（CT）等检查发现肺部有活动性病灶）。

鉴定要点：细菌学检查：涂片、培养 阳性；分子生物学检查 阳性；组织病理学检查为结核病变；胸部 X 线摄影或胸部电子计算机体层摄影（CT）等检查发现肺部有活动性病灶）任何一项可认定为活动性结核病。

十四、房颤

界定永久性房颤，凭心电图确诊为房颤，排除首诊房颤、阵发性房颤、持续性房颤、长期持续性房颤，确诊永久性房颤要求持续时间>1 年,不能终止或终止后又复发，无转复愿望。

鉴定要点：现场鉴定：至少每个季度内心电图检测到房颤一次，年度内累计 4 次以上。

十五、慢性阻塞性肺疾病

（一）确诊慢性支气管炎、肺气肿，即符合慢性支气管炎、肺气肿诊断标准（本处从略）；

（二）肺功能检查，要求 $FEV1/FVC < 0.7$ 。

基础疾病为支气管哮喘、支气管扩张症、肺纤维化、间质性

肺疾病、严重的肺结核等不能诊断 COPD。

备注：肺气肿虽在内科学第七版上已经将其降为病理诊断名词，不再做单病论述，但诊断标准仍按旧版内科学论述为准。

以上（一）、（二）同时符合标准，界定成立。

鉴定要点：审查病历资料鉴定并结合现场鉴定。至少要求提供三级乙等医院（含以上）诊断慢阻肺的完整住院病历，同时结合现场鉴定，根据标准由专家对病历及现场鉴定结果进行核定。

十六、真性红细胞增多症

（一）主要诊断指标 1.红细胞容量大于正常预期值的 25% 以上，或男性 HCT 大于 0.60、女性 HCT 大于 0.56；2.无引起继发性红细胞增多症的病因（正常动脉血氧饱和度，无 EPO 水平升高）；3.可触及的脾大；4.造血细胞存在 JAK2/v617F 突变或其他细胞遗传学异常（BCR/ABL 除外）。

（二）次要诊断指标 1.血小板大于 400×10^9 次方/L；2.中性粒细胞大于 10×10^9 次方/L，吸烟者大于 12.5×10^9 次方/L；3.影像学证实的脾大；4.内生性红细胞集落形成或血清 EPO 水平降低。当存在主要诊断指标 1+2+任一其他主要诊断指标或只要诊断指标 1+2+任两条次要诊断指标时，即可诊断真性红细胞增多症。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院

诊断真性红细胞增多症的完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。

十七、重症肌无力

受累肌肉在活动后出现疲劳无力，经休息或胆碱酯酶抑制治疗可以缓解，肌无力表现为“晨轻暮重”的波动现象。结合药物试验，肌电图以及免疫学等检查的典型表现可以作出诊断。具体典型表现如下：

（一）药物试验：新斯的明试验阳性、腾喜龙试验阳性。

（二）肌电图：重复神经电刺激阳性、单纤维肌电图阳性。

（三）AChR 抗体滴度检测阳性。

对胸腺 CT 或 MRI 示胸腺异常或者甲状腺功能亢进，作为支持诊断。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断重症肌无力的完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。

十八、A 型血友病

（一）临床表现：1.男性患者，有或无家族史，有家族史者符合 X 连锁隐性遗传规律；2.关节、肌肉、深部组织出血，可呈自发性，或发生于轻度损伤、小型手术后，易引起血肿及关节畸形。

(二) 实验室检查: 1.出血时间、血小板计数及 PT 正常;
2.APTT 重型明显延长: 3.FVIII: C 水平明显低下: 4. Vwf:Ag 正常。

鉴定要点: 审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断 A 型血友病的完整住院病历, 根据标准由专家对病历进行核定。

十九、法洛四联症术前治疗

(一) 临床表现: 自幼出现的进行性青紫和呼吸困难, 易疲乏, 劳累后常取蹲踞位休息, 伴有杵状指, 心脏听诊肺动脉瓣第二心音减弱以致消失, 胸骨左缘常可闻及收缩期喷射性杂音。

(二) 心电图: 可见电轴右偏, 右心室肥厚。

(三) X 检查: 主要为右心室肥厚表现, 肺动脉段凹陷, 形成木靴状外形, 肺血管纹理减少。

(四) 超声心动图: 显示右心室肥厚、室间隔缺损、主动脉骑跨、右心室流出道狭窄。

鉴定要点: 审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断法洛四联症的完整病历, 根据标准由专家对病历进行核定。

二十、布氏杆菌病

1.流行病学接触史: 密切接触家畜、野生动物(包括观赏动物)、畜产品、布氏杆菌培养物等, 或生活在疫区的居民; 2.临

床症状和体征应排除其他疑似疾病;3.实验检查:病原分离、试管凝集试验、补体结合试验、抗人球蛋白试验阳性。凡具备第 1.2 项和第三项中的任何一项检查阳性即可确诊为布氏杆菌病。

鉴定要点:审查病历资料鉴定。至少要求提供黑龙江省农垦总局医院诊断的完整病历,根据标准由专家对病历进行核定。

布氏杆菌病活动期给予待遇,治愈后不再享受待遇,故每次申请待遇都要求提供病例资料。

二十一、肌萎缩侧索硬化(ALS)

1、临床表现:一侧或双侧手指活动笨拙、无力,随后出现手部小肌肉萎缩,以大、小鱼际肌、骨间肌、蚓状肌为明显,双手可呈鹰爪形,可累计躯干部和颈部、面肌和咽喉肌。双上肢肌萎缩,肌张力不高,但腱反射亢进,Hoffmann 征阳性;双下肢痉挛性瘫痪,肌张力高,巴宾斯基征阳性。无客观的感觉障碍。延髓麻痹出现舌肌萎缩、束颤和伸舌无力,甚至吞咽困难、咀嚼无力。

2、肌电图:病变处肌肉插入电位延长,纤颤电位,动作电位时限增宽、波幅增高、波形以混合相或单纯相多见,可见巨大电位,延髓、颈、胸与腰骶不同节段神经支配的肌肉出现失神经支配现象。

3、CT 和 MRI 提示脊髓变细。

4、肌肉活检，可见神经源性肌萎缩的病理改变。

以上 1 和 2 的典型表现即可确诊，3 和 4 作为补充诊断。但诊断 ALS 前，必须排除颈椎病、脊髓肿瘤、脊髓空洞症等疾病才可确诊。

鉴定要点：审查病历资料鉴定。至少要求提供三级甲等医院诊断的肌萎缩侧索硬化（ALS）完整住院病历，根据标准由专家对病历进行核定。

